UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Ophtalmologie
Crise aiguë par fermeture de l'angle
Avec patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : LE PENDU Marie Date de rédaction : 6/02/2024

Situation de départ N° 152 – Œil rouge et/ou douloureux

Domaine de compétence n°1 : Entretien/interrogatoire

Domaine de compétence n°1 : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1- Caractériser la douleur oculaire et les signes associés

2- Chercher les signes d'interrogatoire permettant d'orienter l'enquête étiologique

3- Initier la prise en charge d'une crise aiguë de fermeture de l'angle

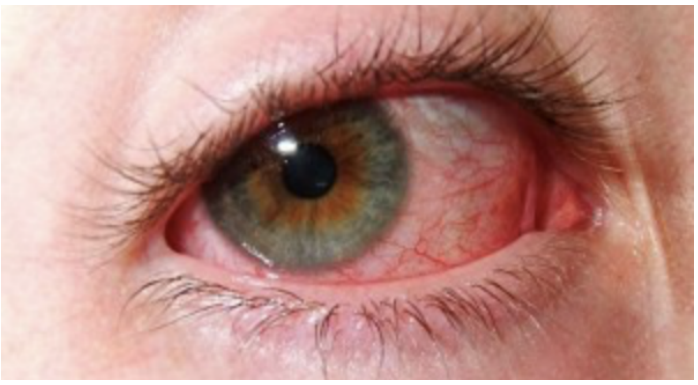
Patient simulé nécessaire à la station : OUI Femme de 63 ans

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Photo

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS



Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autre que ce qui est précisé.

Synopsis : Vous êtes une femme de 63 ans se présentant aux urgences pour trouble de la vision et douleur de l'œil droit depuis ce matin au réveil. Vous avez été amené aux urgences par votre mari.

Un étudiant en médecine va vous interroger et vous examiner.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Daniel Prénom : Monique Âge : 63 ans Retraitée Marié, 3 enfants Habite dans le centre de Nice
Antécédents	Parkinson Hypermétropie
Médicaments actuels/ Toxiques	*Antiparkinsoniens* *Anxiolytiques en si besoin*
Etats d'esprit/ comportement	Posture assise Douleur : forte Angoisse : forte Colère : faible
Déroulement du scénario	Vous êtes assise Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : ***Depuis ce matin, j'ai mal à l'œil et j'ai l'impression de voir moins bien et cela m'inquiète beaucoup.*** Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement. La photo sera présentée au patient en arrivant dans la salle.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Quelles sont vos antécédents ?	Parkinson, hypermétropie
Prenez- vous des traitements ?	Antiparkinsoniens, anxiolytiques en si besoin
Avez-vous des allergies ?	NON
Consommez-vous du tabac ? de l'alcool ? des drogues ?	NON, NON, NON
Vous avez mal aux 2 yeux ou seulement à l'un ? Lequel ?	Un seul, le droit
Depuis combien de temps avez-vous mal ?	Ce matin (sans préciser l'horaire exacte)
L'apparition a été brutale ?	Oui, 9h précisément
Étiez-vous en train de faire quelque chose de particulier? (élimination du contexte de traumatisme)	Non, je venais de me réveiller
Vous y voyez moins bien ?	OUI
Avez- vous des nausées et/ou des vomissements ?	NON
Sur une échelle de douleur de 0 à 10, à combien côteriez-vous la douleur ?	8/10 (sévère si autre échelle donnée)
La douleur irradie-t-elle ?	NON
C'est le premier épisode de ce genre ?	OUI

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne au service des urgences de votre ville et vous recevez Mme. Daniel, 63 ans pour douleurs et troubles de la vision depuis ce matin.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Réaliser l'interrogatoire général et ciblé de la patiente ainsi que la recherche de facteurs de risque de cette pathologie.
2. Expliquer les grands principes de la prise en charge

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
Réalisation de l'interrogatoire général : antécédents personnels et familiaux, prise de toxiques (tabac et/ou alcool et/ou drogues), allergies, mode de vie, traitements Point si minimum 4/5 demandés	
Recherche la localisation de l'œil douloureux	
Interroge sur le type de douleur	
Interroge sur l'intensité de la douleur	
Interroge sur la temporalité de la douleur (brutale/progressive)	
Interroge sur la notion d'un traumatisme	
Interroge sur la présence d'une rougeur oculaire ou confirme grâce à la photographie la présence d'une rougeur	
Interroge sur la présence de troubles visuels : baisse d'acuité visuelle, métamorphopsies, myodésopsies, phosphènes, photophobie, larmoiement, blépharospasme, micro/macropsies, scotome, atteinte du champs visuel, atteinte de la vision des couleurs, éclipses visuelles Point si minimum 6/12 demandés	
Interroge sur les facteurs de risque de crise aiguë par fermeture de l'angle : hypermétropie, obscurité, stress, exercice physique, antihistaminiques, antidépresseurs, antiparkinsoniens, vasoconstricteurs, anxiolytiques, anticholinergiques Point si minimum 4/10 demandés	
Tâche 2	
Préciser que le traitement est urgent	
Préciser l'utilisation de **collyres hypotonisants** en précisant au moins une classe parmi : beta-bloquants, prostaglandines, alpha-2-adrénergique, inhibiteur de l'anhydrase carbonique)	
Préciser l'utilisation **d'agents déshydratant** le globe oculaire par **voie générale** sans préciser les classes nécessairement(acétazolamide et mannitol)	
Préciser l'utilisation d'un **collyre myotique**	
Préciser la nécessité d'une iridotomie laser de l'œil atteint **et** de l'œil controlatéral	
Préciser que l'iridotomie laser doit être réalisée après la réduction de la pression intra-oculaire et/ou la réduction de l'œdème cornéen	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à questionner	1 à 5
Aptitude à structurer/mener l'entrevue	
Aptitude à proposer une prise en charge	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tâche 1	
Réalisation de l'interrogatoire général : antécédents personnels et familiaux, prise de toxiques (tabac et/ou alcool et/ou drogues), allergies, mode de vie, traitements Point si minimum 4/5 demandés	1
Recherche la localisation de l'œil douloureux	1
Interroge sur le type de douleur	1
Interroge sur l'intensité de la douleur	1
Interroge sur la temporalité de la douleur (brutale/progressive)	1
Interroge sur la notion d'un traumatisme	1
Interroge sur la présence d'une rougeur oculaire ou confirme grâce à la photographie la présence d'une rougeur	1
Interroge sur la présence de troubles visuels : baisse d'acuité visuelle, métamorphopsies, myodésopsies, phosphènes, photophobie, larmoiement, blépharospasme, micro/macropsies, scotome, atteinte du champs visuel, atteinte de la vision des couleurs, éclipses visuelles Point si minimum 6/12 demandés	1
Interroge sur les facteurs de risque de crise aiguë par fermeture de l'angle : hypermétropie, obscurité, stress, exercice physique, antihistaminiques, antidépresseurs, antiparkinsoniens, vasoconstricteurs, anxiolytiques, anticholinergiques Point si minimum 4/10 demandés	1
Tâche 2	
Préciser que le traitement est urgent	1
Préciser l'utilisation de **collyres hypotonisants** sans préciser les classes nécessairement (4 classes possibles : beta-bloquants, prostaglandines, alpha-2-adrénergique, inhibiteur de l'anhydrase carbonique)	1
Préciser l'utilisation **d'agents déshydratant** le globe oculaire par **voie générale** sans préciser les classes nécessairement(acétazolamide et mannitol)	1
Préciser l'utilisation d'un **collyre myotique**	1
Préciser la nécessité d'une iridotomie laser de l'œil atteint **et** de l'œil controlatéral	1
Préciser que l'iridotomie laser doit être réalisée après la réduction de la pression intra-oculaire et/ou la réduction de l'œdème cornéen	1
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à questionner	3
Aptitude à structurer/mener l'entrevue	
Aptitude à proposer une prise en charge	